

DATOS DEL PACIENTE	
Nombre y Apellidos:	
Nº Afiliación / NUHSA:	Edad:
DATOS DEL FACULTATIVO PRESCRIPTOR	
Nombre y Apellidos:	
CNP:	
Servicio o Unidad y Centro Sanitario:	
Firma:	Fecha:

1. TRATAMIENTO INDICADO					
☐ Diagnóstico principal: fibrilación auricular no valvular (FANV). ☐ Codificación del diagnóstico (CIE-9): 427.31 ☐ Indicación principal: prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con FANV con uno o más factores de riesgo tales como: ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos, edad mayor o igual 75 años, hipertensión, diabetes mellitus o insuficiencia cardíaca sintomática [mayor o igual Clase 2 escala New York Heart Association (NYHA)].			☐ Diagnóstico principal: cirugía de reemplazo total de cadera o rodilla, programadas en ambos casos. ☐ Codificación del diagnóstico (CIE-9): V43.64 (cadera) ☐ Codificación del diagnóstico (CIE-9): V43.65 (rodilla) ☐ Indicación principal: prevención primaria de episodios tromboembólicos venosos en pacientes adultos.		
2. POSOLOGÍA					
2.1. TRATAMIENTO EN FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR					
☐ Dabigatrán 150 mg/12 h ☐ Dabigatrán 110 mg/12 h		☐ Rivaroxabán 20 mg/24 h ☐ Rivaroxabán 15 mg/24 h		☐ Apixabán 5 mg/12 h ☐ Apixabán 2,5 mg/12 h	
				☐ Edoxabán 60 mg/24 h ☐ Edoxabán 30 mg/24 h	
2.2. PREVENCIÓN PRIMARIA EN EPISODIOS TROMBOEMBÓLICOS VENOSOS EN ADULTOS SOMETIDOS A CIRUGÍA DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA O RODILLA					
	Dabigatrán		Rivaroxabán	Apixabán	Edoxabán
Posología de inicio	☐ 75 mg/24 h	☐ 110 mg/24 h	☐ 10 mg/24 h	☐ 2,5 mg/12 h	No está financiado
Posología de mantenimiento	☐ 150 mg/24 h	☐ 220 mg/24 h	☐ 10 mg/24 h	☐ 2,5 mg/12 h	
Duración máxima:					
Cadera	☐ 28-35 días		☐ 35 días	☐ 32-38 días	
Rodilla	☐ 10 días		☐ 14 días	☐ 10-14 días	
Aclaramiento de creatinina (AclCr) _____					
3. NECESIDAD DE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORAL EN FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR (Realice evaluación riesgo CHA ₂ DS ₂ -VASc y marque la situación clínica que proceda)					
3.1. Evaluación del riesgo tromboembólico: ☐ Puntuación CHA₂DS₂-VASc ≥2: Resultado puntuación: _____ - Factores de riesgo necesarios: insuficiencia cardíaca NYHA ≥2 (1 punto); hipertensión arterial (1 punto); edad ≥75 años (2 puntos); diabetes mellitus (1 punto); ictus o ataque isquémico transitorio previo (2 puntos). - Otros factores de riesgo: enfermedad vascular: enfermedad arterial periférica, infarto de miocardio (1 punto), sexo femenino (1 punto), edad 65-74 años (1 punto). El sexo del paciente y la enfermedad vascular carecen de una evidencia de consistencia similar a la del resto de factores de riesgo. Por tanto, en pacientes con puntuación CHA ₂ DS ₂ -VASc ≥2 por estos dos factores, debe valorarse con especial cuidado el balance beneficio/riesgo de la terapia anticoagulante oral.					

3.2. Presencia de al menos una de las siguientes actuaciones:

- ☐ Alergia o hipersensibilidad demostrada a cumarínicos, reacciones adversas graves asociadas al tratamiento con antagonistas de la vitamina K (aVK), contraindicaciones específicas para el uso de aVK o presencia de una interacción farmacológica relevante, de difícil control a pesar del ajuste posológico en función del INR (que no haya sido descrita para los anticoagulantes orales directos).
- ☐ Antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC) (excepto durante la fase aguda).
- ☐ Ictus isquémico con criterios de alto riesgo de HIC, definido como HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los siguientes criterios clínicos: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados corticales múltiples.
- ☐ Pacientes en tratamiento con aVK que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control del INR*.
- ☐ Pacientes que han iniciado tratamiento con aVK y tienen mal control del INR* (no motivado por falta de adherencia al tratamiento). Indicar valor INR: _____
- ☐ Imposibilidad de acceso al control de INR convencional en los centros sanitarios, o no disponer de enfermería de enlace o cuidados de hospitalización domiciliaria.

**Se considerará que el control del INR es adecuado cuando el porcentaje de tiempo en rango terapéutico sea $\geq 65\%$, calculado mediante el método de Rosendaal, o cuando el porcentaje de determinaciones dentro de rango terapéutico (2-3) sea $\geq 60\%$, cuando no sea posible utilizar este método (considerando las determinaciones correspondientes a un periodo de un año, o al menos 6 meses en casos de un claro mal control, y excluyendo los INR del primer mes (en caso de ajuste inicial de dosis) o periodos de cambio debidos a intervenciones quirúrgicas o dentales u otros procedimientos invasivos, etc.).*

4. PRECAUCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS

- ✓ Considerar la capacidad del paciente y/o cuidador para entender el riesgo/beneficio de la anticoagulación.
- ✓ Insistir en el buen cumplimiento terapéutico según las instrucciones del nuevo tratamiento.
- ✓ Ajustar las dosis según aclaramiento de creatinina, peso y edad (reevaluar posibles cambios con una periodicidad mínima anual):

	Dabigatrán	Rivaroxabán	Apixabán	Edoxabán
Ajuste de dosis	110 mg/12 h	15 mg/24 h	2,5 mg/12 h	30 mg/24 h 15 mg/24 h*
Criterios para el ajuste de dosis	Alguno de los siguientes criterios: • Edad ≥ 80 años • Toma concomitante de verapamilo • Riesgo hemorrágico aumentado	AclCr 15-49 ml/min	AclCr 15-29 ml/min o al menos 2 de los siguientes criterios: • Peso ≤ 60 kg • Edad ≥ 80 años • Creatinina sérica $\geq 1,5$ mg/dl (133 μmol/l)	Alguno de los siguientes criterios: • Peso ≤ 60 kg • AclCr 15-50 ml/min • Toma concomitante de dronedarona, ciclosporina, eritromicina o ketoconazol
Recomendaciones en insuficiencia renal	Contraindicado en AclCr < 30 ml/min	No recomendado en AclCr < 15 ml/min	No recomendado en AclCr < 15 ml/min	No recomendado en AclCr < 15 ml/min
Precauciones específicas	Debe evitarse la administración conjunta de dabigatrán con inductores de la glicoproteína-P (rifampicina, hierba de San Juan, fenitoína o carbamazepina).	Debe evitarse la administración conjunta de rivaroxabán y dronedarona. No se recomienda el tratamiento sistémico concomitante de rivaroxabán o apixabán con antimicóticos azólicos (ketoconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol) o inhibidores de la proteasa (incluyendo ritonavir y sus combinaciones). Apixabán y rivaroxabán contienen lactosa: los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.	Debe realizarse pruebas de función hepática antes de iniciar el tratamiento.	Debe realizarse pruebas de función hepática antes de iniciar el tratamiento.

AclCr: aclaramiento de creatinina

***Edoxabán 15 mg** no está indicado como monoterapia ya que puede dar lugar a una disminución de la eficacia. Solo está indicado en el proceso de cambio de edoxabán 30 mg a aVK, junto con una dosis de aVK adecuada.

5. CONTRAINDICACIONES <i>(Por la seguridad del paciente, revise que NO se presenta)</i>	
Contraindicaciones generales al tratamiento con anticoagulantes orales (ya sea con aVK o ACOD)	
• Paciente poco colaborador y que no esté bajo supervisión • Embarazo (si procede) y lactancia • Cirugía reciente o prevista en el sistema nervioso central • Enfermedades hepáticas o renales graves	• Alergia al principio activo o excipientes • Hemorragia aguda en las 2 últimas semanas • Hipertensión arterial grave y/o no controlada • Alteración de la hemostasia hereditaria o adquirida con riesgo clínicamente relevante de hemorragia
Contraindicaciones específicas de los ACOD	
• Lesiones o enfermedades con un riesgo significativo de hemorragia mayor (úlceras gastrointestinales activas o recientes, neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, lesión espinal o cerebral reciente, cirugía espinal u ocular, hemorragia intracraneal reciente, varices esofágicas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales importantes). • Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, excepto bajo circunstancias de cambio de terapia entre ellos. Tratamiento concomitante dabigatrán con ketoconazol por vía sistémica, ciclosporina, itraconazol, tacrolimus y dronedarona. • AclCr <30 ml/min (dabigatrán). • Prótesis valvulares cardíacas (dabigatrán). • Insuficiencia o enfermedad hepática que pueda afectar a la supervivencia (dabigatrán). • Hepatopatía asociada a coagulopatía y con riesgo clínicamente relevante de hemorragia (apixabán, edoxabán y rivaroxabán), incluidos los pacientes cirróticos con Child Pugh B y C (rivaroxabán).	
6. INFORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA PROCEDER AL VISADO	
Sin esta información el operador de visado no tiene capacidad de poder autorizar/denegar dicho visado. Se necesitarán los siguientes datos, como en el siguiente <u>ejemplo de APIXABÁN</u>: <u>Juicio clínico (corresponde a diagnóstico principal)</u>: fibrilación auricular no valvular <u>Indicaciones (corresponde a indicación principal)</u>: CHA₂DS₂ –VAsC =4 (mujer, de 68 años, diabética e hipertensa) Criterios específicos: hipersensibilidad demostrada a cumarínicos y un aclaramiento de creatinina de 60ml/min. Por motivos de seguridad del paciente, se recomienda aportar el valor del aclaramiento de creatinina <i>Detallar los criterios específicos sobre las condiciones de utilización cumplimentando el punto 3, indicando la puntuación CHA₂DS₂ –VAsC y la presencia de, al menos, una de las situaciones recogida en el apartado segundo (3.2).</i> <u>Código CIE-9</u> : 427.31 <u>Diagnóstico</u>: FIBRILACIÓN AURICULAR	

Fuentes consultadas:

Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos. BOE nº 114 de 12/05/2007.

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, sobre gestión y control del visado de recetas. BOJA nº 245 de 23/12/2021. <https://juntadeandalucia.es/boja/2021/245/39>

Informe de posicionamiento terapéutico UI ACOD/V5/21112016. Criterios y recomendaciones generales para el uso de los anticoagulantes orales directos (ACOD) en la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular. AEMPS. Noviembre 2016.

Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos: BIFIMED.
<https://www.msbs.gob.es/profesionales/medicamentos.do>

Ficha técnica de los medicamentos Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® y Lixiana®. Consultado CIMA AEMPS. Diciembre 2021.
<https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html>